



Protocolo de Segurança do Paciente

Documento educacional baseado em referências reconhecidas de segurança do paciente. Não representa protocolo de uma instituição específica.

Finalidade

Reunir orientações gerais baseadas em práticas nacionais de segurança do paciente para uso como base de conhecimento do MedFlow AI.

1. Identificação do paciente

Confirmar a identidade com pelo menos dois identificadores antes de procedimentos e cuidados.

Manter identificação legível e compatível com os dados do prontuário.

Em pacientes que não podem responder, utilizar fontes seguras previstas pelo serviço, como responsável, documentos e registros institucionais.

2. Cirurgia segura

A segurança cirúrgica envolve confirmação do paciente, procedimento e local corretos e uso de lista de verificação de cirurgia segura.

A lista de verificação é organizada em momentos críticos do procedimento, incluindo antes da indução anestésica, antes da incisão e antes de o paciente deixar a sala, conforme adaptação institucional.

A equipe deve compartilhar informações críticas, incluindo alergias, risco de perda sanguínea, dificuldades previstas e outras condições relevantes.

3. Prevenção de quedas

O risco de queda deve ser avaliado na admissão utilizando instrumento adequado ao perfil do serviço e reavaliado conforme condição clínica e protocolo institucional.

Medidas preventivas devem ser individualizadas segundo o risco: orientação ao paciente/família, ambiente seguro, auxílio na mobilidade e outras medidas previstas pelo serviço.

Quedas e circunstâncias relacionadas devem ser registradas e tratadas conforme fluxo de notificação e segurança da instituição.

4. Segurança de medicamentos

Prescrição, dispensação e administração devem seguir práticas de identificação correta do paciente, medicamento, dose, via, horário e demais verificações previstas no protocolo institucional.

Alergias, interações, duplicidades, dúvidas de dose ou prescrição ilegível/incompleta exigem esclarecimento antes da administração.

Medicamentos de alta vigilância requerem barreiras adicionais conforme política institucional.

5. Comunicação segura

Informações críticas devem ser transmitidas de maneira clara e confirmável entre profissionais, especialmente em transferências de cuidado.

Resultados críticos, mudanças clínicas, alergias, pendências e riscos relevantes devem ser comunicados ao profissional responsável e registrados conforme o fluxo institucional.

Referências-base

- Ministério da Saúde / ANVISA / Fiocruz - Protocolos Básicos de Segurança do Paciente: identificação do paciente, cirurgia segura, prevenção de quedas e segurança no uso de medicamentos.
- RDC ANVISA nº 36/2013 - ações para segurança do paciente em serviços de saúde.
- Conselho Federal de Medicina - Resolução CFM nº 1.638/2002 (prontuário médico) e Recomendação CFM nº 1/2016 (consentimento livre e esclarecido).
- American Society of Anesthesiologists - Practice Guidelines for Preoperative Fasting (referência internacional para jejum em procedimentos eletivos: aplicação depende da avaliação anestésica e do protocolo institucional).

Nota de uso: material preparado para projeto acadêmico de RAG. Na assistência real, prevalecem legislação vigente, protocolos institucionais e avaliação dos profissionais responsáveis.